

Prova 3 terapia nutricional

- O tratamento nutricional no diabetes tipo 2 envolve uma abordagem integrada entre alimentação, medicação, atividade física e monitorização glicêmica, com o objetivo de melhorar o controle glicêmico, reduzir complicações e, em alguns casos, até alcançar remissão da doença.

- A contagem de carboidratos é uma das principais estratégias utilizadas, especialmente em pacientes que utilizam insulina. Ela consiste em ajustar a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidratos consumidos. Dentro dessa estratégia, existem conceitos importantes como o bolus de refeição, que corresponde à quantidade de insulina necessária para cobrir os carboidratos ingeridos, e o bolus de correção, que é utilizado para corrigir uma glicemia elevada. Existe também o fator de sensibilidade, que indica o quanto a glicemia reduz com determinada quantidade de insulina. De forma geral, utiliza-se a regra 1:15, em que uma unidade de insulina cobre aproximadamente 15 g de carboidrato, e fórmulas como 400 dividido pela insulina total do dia para calcular o bolus alimentar e 2000 dividido pela insulina total do dia para o fator de correção.

- Os alimentos podem ser organizados em listas de equivalentes, que agrupam alimentos com quantidades semelhantes de carboidratos, facilitando o planejamento alimentar e a substituição de alimentos sem comprometer o controle glicêmico.

- No tratamento medicamentoso, a metformina é a principal droga da classe das biguanidas, atuando principalmente na redução da produção hepática de glicose e melhorando parcialmente a sensibilidade à insulina. Ela reduz a glicemia e a hemoglobina glicada, melhora o perfil lipídico e não apresenta risco significativo de hipoglicemia. Entretanto, pode estar associada à deficiência de vitamina B12, sendo necessária a avaliação periódica dessa vitamina, especialmente em pacientes que utilizam doses elevadas por longos períodos.

- Outra classe importante são os inibidores de SGLT2, que atuam inibindo a reabsorção de glicose nos túbulos renais, promovendo sua excreção urinária. Eles apresentam baixo risco de hipoglicemia, podem levar à perda de peso e são associados a efeitos adversos como infecções genitais e desidratação.

- Os hormônios incretínicos, como GLP-1 e GIP, desempenham papel fundamental na regulação da glicose. Eles aumentam a secreção de insulina, reduzem a secreção de glucagon e melhoram a sensibilidade à insulina. Os análogos de GLP-1 são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, promovendo redução da glicemia, diminuição do apetite, lentificação do esvaziamento gástrico e perda de peso.

- Em relação à dieta, estratégias como dietas com baixo teor de carboidratos podem ser utilizadas, mas exigem cuidado, especialmente quando associadas a inibidores de SGLT2, devido ao risco de cetoacidose euglicêmica, principalmente em situações de jejum, desidratação ou ingestão calórica reduzida.

- A perda de peso é um dos pilares do tratamento do diabetes tipo 2, sendo capaz de melhorar significativamente o controle glicêmico e até promover remissão da doença. Estudos mostram que uma perda de cerca de 15 kg pode levar à remissão em uma parcela significativa dos pacientes, especialmente aqueles com diagnóstico recente. A remissão é definida como hemoglobina glicada menor que 6,5% sem uso de medicação por um período mínimo.

- Durante a perda de peso, cerca de 75% da redução corresponde à massa gorda e 25% à massa magra, o que reforça a importância de ingestão adequada de proteínas, geralmente entre 1,2 a 1,5 g/kg/dia, para preservar massa muscular.

- A obesidade sarcopênica, caracterizada pela associação entre excesso de gordura e redução de massa e função muscular, é uma condição relevante no diabetes tipo 2, especialmente em idosos, e está associada a piores desfechos clínicos.

- A automonitorização glicêmica é fundamental para o controle da doença, permitindo ajustes na alimentação, atividade física e doses de insulina. Recomenda-se múltiplas medições ao longo do dia, incluindo jejum, antes e após refeições e antes de dormir.

- Além disso, existem tecnologias como a monitorização contínua de glicose, que utilizam sensores intersticiais para medir a glicose a cada poucos minutos, fornecendo dados mais completos, incluindo tempo no alvo e alertas de hipoglicemia.